

骶骨阴道固定术

WARWIKI

患者须知 · 持久有效的补片支撑，用于阴道顶端脱垂修复

骶骨阴道固定术是修复阴道顶端或子宫脱垂最持久的手术方式之一。手术使用柔软的补片托举阴道顶端，并将其固定在骶骨（尾骨）上方的坚韧韧带上，从而恢复阴道的自然位置和深度。通常采用微创（机器人或腹腔镜）手术完成，术后可保留性生活能力。

关于这项手术

手术将一块**补片**缝合在阴道顶端的前壁和后壁，再固定到**骶骨**上方的坚韧韧带上，使阴道恢复正常位置。由于远期效果优异，该手术被视为顶端脱垂修复的**金标准**术式。

关于补片

本手术使用的补片经**腹部**途径植入，安全性经过充分研究和验证。它与曾受FDA警告并已退市的经阴道脱垂补片**不同**。您的医生会详细说明相关风险，包括极少数情况下可能出现的补片暴露。

名词解释

顶端／穹窿

阴道最顶部，分娩或子宫切除后可能下垂。

骶骨

脊柱末端的骨骼，其上的韧带用于固定补片。

补片

用于支撑阴道顶端的柔软永久性材料。

机器人／腹腔镜手术

通过几个小切口完成的微创手术。

补片暴露

少见并发症，指少量补片外露，可处理。

子宫切除术

切除子宫，有时在同次手术中一并完成。

会疼吗？ 手术在**全身麻醉**下进行，术中不会有任何感觉。微创手术后，多数患者仅有小切口处轻度酸痛和些许腹胀不适，当天或住院一晚后即可出院。若采用开腹手术，恢复时间会稍长。

如何准备

- 手术在**全身麻醉**下进行 — 请遵照禁食和用药指示（按医嘱停用抗凝药）。
- 术前需完成术前评估；可能同时进行**子宫切除**和/或**尿失禁**手术。
- 请戒烟，安排好接送和术后家庭照护。

手术过程

- 1 您处于麻醉状态，同时预防性使用抗生素。
- 2 通过微创小切口（或一个开腹切口），将补片缝合于阴道顶端。
- 3 补片固定于骶骨韧带，将阴道托举复位。
- 4 短期留置导尿管。

术后注意事项

- 当天或住院一晚后出院，初期以轻度活动为主。
- **约6周内避免重体力劳动、用力排便和性生活。**
- 少量阴道出血和轻度不适属正常现象，注意预防便秘。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒
- 大量出血，或腹部、盆腔疼痛加重
- **无法排尿**，或持续恶心/呕吐
- 阴道分泌物有异味，或后期出现性交疼痛（可能提示补片问题）

需要记住的三件事

1. 骶骨阴道固定术通过将补片固定于骶骨，托举阴道顶端 — 是顶端脱垂最持久的修复方式，通常采用微创手术。
2. 手术使用的腹部补片经充分验证，与已召回的经阴道脱垂补片不同。
3. 术后约6周内避免重体力劳动和性生活。如出现发热、大量出血、无法排尿或后期异味/疼痛，请及时联系医疗团队。